

إسم المريض رباعياً : إيمان حمدي رمضان صقر
المحافظة : الجيزة
رقم البطاقة : 27109011603169 رقم التليفون : 01123283293
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-09-1971 المهنة : ربه منزل
العنوان : 6 عيد عبد الوهاب
تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي (-----)

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى : قسم :
 جهة العلاج : نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: إيمان حمدي رمضان صق
National ID: 27109011603169



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



Name : Elman Hamdi Ramadan I :

Sakr

Code :R2695592

Date 12/5/2022

Tc^{99m} MDP BONE SCAN:

Procedure:

- Simultaneous anterior and posterior whole body bone scan and spot views were obtained 2 hours post injection of 22 mCi of the radiotracer.

Previous Imaging:

- No previous bone scan or relevant imaging available for comparison.

Findings:

- Warm focal tracer uptake observed at the right aspect of LV3
- No other significant findings detected at the rest of the skeleton show normal tracer distribution pattern

Opinion:

- Single warm tracer uptake observed at the right aspect of LV3 warrant correlation with CT (bone window) or regional MRI in order to establish the exact nature as the bone scan is not specific in characterization of single lesion especially if it is warm and low grade .

Best Regards

Dr.Maha Abd Elkareem,M.D.

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on
radreport@cairoscan.com.eg



Patient Name : الأستاذة / ايمان حمدي رمضان صقر	Request No. : 13006372
Patient No. : 27109011603169	Request Date : 14/12/2022
Path No. : 3765/22	Verification Date : 25/12/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 51 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, (post neoadjuvant therapy)
Nature of the specimen: Right MRM

Gross Examination:

Right MRM measuring 20x13x7 cm, with skin covering; 20x11 cm. Cut section revealed an ill-defined firm grayish white tumor bed site measuring 8x7.5x2.5 cm, located 3cm away from deep resection margin respectively. There was a piece of attached muscle measured 9x4 cm. Dissection of axilla revealed 11 lymph nodes measured up to 1.5x1.5 cm.

Microscopic examination:

- No remnants of tumor tissue
- Complete pathological response
- Angiolinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: Free (0/11)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Hyalinosis and fibrosis.
- Additional pathologic findings: No lymphatic tumor emboli & No Perineural invasion

Diagnosis:

Right breast cancer, Right MRM (post neoadjuvant);
No remnants of tumor tissue
Complete pathological response
Free resection margins.
Free lymph nodes (0/11)
Stage: ypT0 ypN0

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 01/01/2023 13:03:14

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

Patient Name: Eman Hamdy Ramadan Sakr	Date : 07/12/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 1319/2022	Pat. ID: 14949

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had right MRM

Technique

- left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- scattered fibroglandular densities of the left breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No left breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah
07/12/2023 2:09 PM

Patient Name: Eman Hamdy Raniadan Sakr	Date : 20/11/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 1319/2022	Pat. ID: 14949

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of right breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Heterogenous dense breast parenchyma (ACR C)
- Right UOQ suspicious microcalcifications yet with no residual spiculated mass lesions.
- No left breast spiculated mass lesion or suspicious calcifications.

Complementary ultrasound :

- Regressive course regarding previously mentioned right breast 12 o'clock spiculated lesion.
- No left cystic or solid mass lesions.
- Normal left skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts
- Right axilla multiple enlarged LNs with effaced hilum largest measures 0.9 x 1.6 cm
- Nonspecific left axillary LN

Opinion:

- Right breast proven carcinoma showing residual suspicious calcifications with ipsilateral pathological axillary LNs (BIRADS6)
- Normal left breast study (BIRADS1)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes
20/11/2022 3:35 PM



تاريخ الإصدار: 2023-1-18

جهة الإصدار: فرع الجزيرة

الى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للائتمان الخاصين للقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والأرامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة العاملة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) ايمان حمدي ومضان بطاقة رقم 27109011603169
وطبقا الى خطم، من التأمينات الاجتماعية وأيد عدم الأئتمان
باعتبار من الفئات غير المستفيدة بالتأمين الصحي
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2023-1-18

الموظف المختص

مضى أحمد

الإدارة مركز نظم المعلومات
بمكتب

مستقبل 352172



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغير حالة المواطن من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



Name : Elman Hamdi Ramadan I :
Sakr

Code :R2695592

Date 12/5/2022

Tc^{99m} MDP BONE SCAN:

Procedure:

- Simultaneous anterior and posterior whole body bone scan and spot views were obtained 2 hours post injection of 22 mCi of the radiotracer.

Previous Imaging:

- No previous bone scan or relevant imaging available for comparison.

Findings:

- Warm focal tracer uptake observed at the right aspect of LV3
- No other significant findings detected at the rest of the skeleton show normal tracer distribution pattern

Opinion:

- Single warm tracer uptake observed at the right aspect of LV3 warrant correlation with CT (bone window) or regional MRI in order to establish the exact nature as the bone scan is not specific in characterization of single lesion especially if it is warm and low grade .

Best Regards

Dr.Maha Abd Elkareem,M.D.

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on
radreport@cairoscan.com.eg

Patient Name: Eman Hamdy Ramadan Sakr	Date : 11/12/2022
Exam : C.T CHEST	Age : 51 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Left lower lung lobe shows rounded subpleural nodule measuring 8 mm with regular outer margin.
- Otherwise; clear both lung fields
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Right breast shows calcifications with prominent ipsilateral axillary lymph nodes for better ultrasonographic correlation.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- Left lower lung lobe shows rounded subpleural nodule for follow up.

Dr. Moataz Adel, MSc.

Dr. Ola Magdy, M.D.